Zdravotnictví potřebuje změnu. Máme plán a hledáme pro něj podporu.

Chceme, aby každý měl svého lékaře a svou sestru blízko domova, aby nemocnice dostaly jasnou roli a aby prevence měla stálé peníze.

1 Máme problém

200 → 509 tisíc

Přibývá lidí, kteří potřebují péči

Lidí nad 85 let je dnes 200 tisíc, v roce 2050 jich bude 509 tisíc. Těch, kdo se o ně postarají a kdo na péči vydělají, bude méně.

Zdroj: ÚZIS

5 500 → 3 900 až 4 500

Praktických lékařů ubývá

Praktiků pro dospělé je dnes 5 500, v roce 2035 jich bude 3 900 až 4 500. V obcích do 2 000 obyvatel za čtyři roky zaniklo 428 ordinací a vzniklo jen 291. Svého dětského lékaře nemělo 182 tisíc dětí.

Zdroj: ÚZIS, NRZP

29,7 % : 4,3 %

Peníze končí hlavně na akutních lůžkách

Na akutní lůžka jde 29,7 % plateb pojišťoven, na praktiky pro dospělé 4,3 %. Akutní lůžka jsou přitom obsazená z 56 %, lůžka pro doléčení a dlouhodobou péči z 85,4 %.

Zdroj: ÚZIS 2024

70 mld. Kč

Pojištění bude chybět peněz i bez reformy

V roce 2038 bude zdravotnímu pojištění chybět 70 mld. Kč ročně, i kdyby se nic neměnilo. Péče na dnešní úrovni se udrží, jen když lidé budou stonat později a méně.

Zdroj: Národní rozpočtová rada 2026

2 Nabízíme řešení

1 Svůj lékař a svoje sestra blízko domova

Praktici se mohou dobrovolně spojit do týmu s víc sestrami. Sestra jezdí i za pacienty domů.

2 Ke specialistovi podle toho, jak to spěchá

Lékař v žádance zaškrtne: do 2 týdnů, do 6 týdnů, nebo plánované. Pojišťovna ručí za termín.

3 Nemocnice dostanou novou roli

Okresní nemocnice dostane jistou roli: doléčení, rehabilitaci, jednodenní chirurgii a ambulance.

4 Prevence, která má stálé peníze

Daně z tichého vína a slazených nápojů: nejméně 5 mld. Kč ročně, z toho nejméně 40 % na prevenci.

5 Stáří a konec života doma, když si to člověk přeje

V každém okrese mobilní paliativní tým, aby lidé mohli stáří a konec života prožít doma, pokud chtějí.

Co to stojí, kdy a jak se zapojit: na druhé straně →

Co to stojí

21,5 mld. Kč
ročně, až reforma poběží naplno kolem roku 2038 (odhad 15 až 25 mld. Kč), necelá 4 % dnešních výdajů zdravotního pojištění

520 týmů
lékařů a sester blízko domova a asi 4 000 sester navíc

8 000 lůžek
změní účel na doléčení a rehabilitaci, žádné dřív, než je náhrada

5 mld. Kč
ročně z daní na tiché víno a slazené nápoje, nejméně 40 % na prevenci

Kdy

do 31. 3. 2027	první kolo připomínek k verzi 3.2
2027 a 2028	kulaté stoly a dohody s organizacemi
2028 a 2029	zkouška ve třech regionech
2031 až 2033	zákony, peníze a daně začnou platit
kolem 2038	reforma běží naplno

Co neděláme

- ✕ Žádné nové poplatky u lékaře
- ✕ Dětští lékaři zůstávají
- ✕ Nemocnice zůstanou, změní se jejich role
- ✕ Nic neprodáváme
- ✕ Nikoho nenutíme

3 Detaily jsou ve studii

- Plné znění po kapitolách, s grafy, harmonogramem a závislostmi mezi opatřeními
- Každé číslo má zdroj, rok a definici; co ještě ověřujeme, je v textu označené
- Ekonomický model se třemi variantami podle toho, co se podaří
- Rizika a kontrolní body, na kterých se reforma může zastavit nebo zmenšit

zdraviblizlidem.cz/studie

4 Zapojte se!

Napište připomínku
ke kterémukoli odstavci studie, do 31. 3. 2027

Navrhněte opatření
které v plánu chybí; průvodce vás provede otázkami

Přihlaste se ke kulatému stolu
k tématu, kterému rozumíte; pozvánku pošleme, až bude termín

Ozvěte se za organizaci
chcete se setkat, plán podpořit nebo pomoct s jeho částí

zdraviblizlidem.cz/zapojte-se

Autor: Josef Pavlovic, resortní tým Zdravotnictví. **Kontakt:** pripominky@josefpavlovic.cz

Střet zájmů: Autor plánu je členem Správní rady VZP, členem Pirátské ekonomické expertní rady (PEER) a autorem HSPA Monitoru. Plán navrhuje zkoušku s VZP a mění složení správních rad pojišťoven. Proto o smlouvě na zkoušku rozhoduje vedení VZP, výsledky hodnotí nezávislý hodnotitel a autor se z hlasování o zkoušce vyloučí.